DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: WILSON DAVID ORTEGA CUTIVA **Identificación** CC 1117014596
Edad: 21 AÑOS **Empresa:** COOSALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO-2025
Sala: QUIROFANO 5 **Fecha programación de cirugía:** 07/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	043107	NEURORRAFIA DE NERVIO EN MUSLO	Y43	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	770701	SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE TIBIA O PERONE	Y40	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: PIERNA IZQUIERDA				
1	780501	INJERTO OSEO EN FEMUR	Y42	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	786502	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN FEMUR, VIA ABIERTA	Y39	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	786702	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN TIBIA O PERONE, VIA ABIERTA	Y39	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: PIERNA IZQUIERDA				
1	793501	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN FEMUR (CUELLO, INTERTROCANTERICA, SUPRACONDILEA) CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS)	Y44	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía:				
1	807602	SINOVECTOMIA DE RODILLA TOTAL VIA ABIERTA	Y40	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	814221	CAPSULORRAFIA DE RODILLA	Y38	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	814602	OTRA RECONSTRUCCION O TRANSFERENCIAS PARA LIGAMENTOS MEDIAL O LATERAL	Y43	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	834940	LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO QUIRURGICOS DE MUSCULOS, TENDONES Y FASCIA EN PIERNA	Y38	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: PIERNA IZQUIERDA				
1	837606	TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE MUSLO	Y39	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				
1	867003	COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL DE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS	Y38	
Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA		**Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO				

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES169 FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

043107	**NEURORRAFIA DE NERVIO EN MUSLO**
770501	**SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE FEMUR VIA ABIERTA**
770701	**SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE TIBIA O PERONE**
780501	**INJERTO OSEO EN FEMUR**
786502	**EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN FEMUR, VIA ABIERTA**
786702	**EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN TIBIA O PERONE, VIA ABIERTA**
793501	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN FEMUR (CUELLO, INTERTROCANTERICA, SUPRACONDILEA) CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS)**
807602	**SINOVECTOMIA DE RODILLA TOTAL VIA ABIERTA**
814221	**CAPSULORRAFIA DE RODILLA**
814602	**OTRA RECONSTRUCCION O TRANSFERENCIAS PARA LIGAMENTOS MEDIAL O LATERAL**
834940	**LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO QUIRURGICOS DE MUSCULOS, TENDONES Y FASCIA EN PIERNA**
837606	**TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE MUSLO**
867003	**COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL DE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS**

Dx Preoperatorio: S724 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL FEMUR

Dx Postoperatorio: S724 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL FEMUR

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** BLOQUEO NERVIO **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS

Cantidad de Sangrado: 200 **ml.** **Vía:** DIFERENTE VIA

Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0

Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 07/11/26 **Fecha Final** 07/11/26

Hora Inicio 07:30:00 **Hora Final** 09:14:00

Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

PRIMERA VIA QUIRUGICA / MUSLO & RODILLA IZDA:

DECUBITO SUPINO - ASEPSIA + ANTISEPIA CON CLOROHEXIDINA EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDO - CAMPOS ESTERILES.
EXISTE FRACTURA SUPRA INTERCONDÍLEA DEL FÉMUR IZQUIRDO POR PAF CON ALTO GRADO DE CONMINUCION

SE REALIZA INCISIÓN LONGITUDINAL DE 140 MM EN REGION MEDIAL DEL TERCIO DISTAL DEL MUSLO IZQUIERDO CON EXTENSIÓN HASTA LA RODILLA. DISECCION HASTA EL FOCO DE FRACTURA SUPRACONDILEA DEL FEMUR -
SE REALIZA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN FEMUR IZQUIERDO (PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO) EL CUAL SE ENVIA A CADENA DE CUSTODIA-
SE REALIZA SECUESTRECTOMIA + DRENAJE Y DESBRIDAMIENTO EN FEMUR IZQUIERDO REMOVIENDO REACCIÓN PERIÓSTICA INFLAMATORIA PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE OSTEOMIELITIS,
SE REALIZA MANIOBRAS DE REDUCCION ABIERTA Y SE REALIZA FIJACION INTERNA CON :
MATERIALES UTILIZADOS :
- 1 TORNILLO CANULADOS DE 6,5 X 40 MM AUTOTARRAN
- 1 TORNILLO CANULADOS DE 6,5 X 60 MM AUTOTARRAN
- 1 TORNILLO CANULADOS DE 6,5 X80 MM AUTOTARRAN
- 3 ARANDELAS DE 13 MM
- SE UTILIZA 1 GUIA 1 GUIA ROSCADA DE 2,5 X 300 MM DE FORMA TEMPORAL PARA LA COLOCACION DE LOS TORNILLOS.
NO SE REALIZA FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA POR POBRE ACOPLE DE ESTA AL HUESO - SE VERIFICA EN EL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES ADECUADO EJE ANATOMICO + OSTEOSINTESIS ESTABLE.
SE REALIZA APLICACION DE INJERTO OSEO EN FEMUR IZQUIERDO MEDIANTE TOMA DEL INJERTO OSEO AUTOLOGO ESPONJOSO A TRAVES DE " VENTANA " OSEA EN METAFISIS SANA DE FEMUR DISTAL IPSILATERAL. SE OBTIENE 2 CC DE HUESO ESPONJOSO Y SE APLICA SOBBRE EL DEFECTO DE LA CONMINUCION OSEA .
SE REALIZA DISECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS- EL NERVIO CIATICO POPLITEO INTERNO PRESENTA RUPTURA TRAUMATICA DEL 80% - SE DISECAN FIBRAS, SE REGULARIZAN EXTREMOS IRREGULARES DESVITALIZADOS – SE REALIZA NEURORRAFIA EN MUSLO IZQUIERDO CON TECNICA TERMINO- TERMINAL LOGRANDO RESTABLECER SU ANATOMIA.
SE EVIDENCIA GRAN SINOVITIS POSTRAUMÁTICA DE RODILLA – SE REALIZA SINOVECTOMIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA VIA ABIERTA REMOVIENDO TEJIDO SINOVIAL INFLAMATORIO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR PRONOSTICO FUNCIONAL. LA CAPSULA ARTICULAR PRESENTA RUPTURA TRAUMATICA COMPLETA- SE DISECAN FIBRAS- AVULSIONADAS- SE REGULARIZAN EXTREMOS Y SE REALIZA CAPSULORRAFIA EN RODILLA CON TECNICA DE CAMPBELL PERMITIENDO ADECUADA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

RECONSTRUCCION ANATOMICA-
EXPLORACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS TENDINOSAS Y LIGAMENTARIAS- EXISTE RUPTURA TRAUMATICA DEL 70 % DEL TENDON DEL SARTORIO. DISECCION DE FIBRAS - REGULARIZACION DE LA MISMAS – SE REALIZA RECONSTRUCCION MEDIANTE TRANSFERENCIA MIOTENDINOSA EN MUSLO CON FIBRAS DEL TENDON DE LA FASCIA LATA- SE LOGRA REESTABLECER ANATOMIA ADECUADAMENTE-
SE EXPLORAN ESTRUCTURAS LIGAMENTARIAS DE RODILLA IZQUIERDA--EL LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL PRESENTA AVULSIÓN TRAUMÁTICA COMPLETA EN SU ORIGEN EN EL CONDILO FEMORAL LATERAL CON INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA. SE DISECAN FIBRAS, SE REGULARIZAN EXTREMOS Y SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN LIGAMENTARIA LATERAL CON TECNICA TERMINO TERMINAL, LOGRANDO RESTABLECER ESTABILIDAD ARTICULAR.
SE REALIZA COLGAJO SIMPLE DE PIEL DE 6 X 3 CMS PARA PERMITIR CIERRE DE HERIDA LA CUAL NO PERMITE AFRONTACION PRIMARIA POR EL EDEMA GENERADO EN REGIÓN LATERAL DEL MUSLO . SE DISECA COLGAJO D DEL REGION POSTEROLATERAL DE MUSLO . SE LE DA AVANCE Y SE SUTURA CON PROLENE 3.0 .SE REALIZA LAVADO Y CIERRE DE HERIDA QUIRURTGICA POR PLANOS- CURATIVO CON APÓSITOS.

SEGUNDA VIA QUIRURGICA: PIERNA IZQUIERDA:

SE REALIZA INCISION DE 50 MM EN REGION LATERAL DEL TERCIO PROXIMAL DE LA PIERNA IZDA. DISECCION POR PLANOS
SE REALIZA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN TIBIA IZQUIERDO (PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO) EL CUAL SE ENVIA A CADENA DE CUSTODIA-
SE REALIZA SECUESTRECTOMIA + DRENAJE Y DESBRIDAMIENTO EN TIBIA IZQUIERDA REMOVIENDO REACCIÓN PERIÓSTICA INFLAMATORIA PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE OSTEOMIELITIS.
SE REALIZA LAVADO DE MUSCULOS, TENDONES Y FASCIA EN PIERNA IZQUIERDA REMOVIENDO TEJIDOS DESVITALIZADOS . CIERRE DE HERIDA POR PLANOS - CURATIVO CON APOSITOS .

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
- FRACTURA EXPUESTA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN FÉMUR DISTAL IZQUIERDO (SUPRAINTERCONDILEA)
- ALTO GRADO DE CONMINUCIÓN -
- FRAGMENTOS OSTEOCONDRALES LIBRES A NIVEL INTRA ARTICULAR
- RUPTURA TRAUMATICA DEL 80 % DEL NERVIO CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO
--LA CAPSULA ARTICULAR PRESENTA RUPTURA TRAUMÁTICA COMPLETA.
- RUPTURA TRAUMÁTICA DEL 80 % DEL TENDÓN DEL SARTORIO .
- AVULSIÓN TRAUMÁTICA COMPLETA DEL LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL DE RODILLA IZQUIERDA
- INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA EN RODILLA .
- PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO ALOJADO EN PIERNA IZDA.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES169	FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA	ESPECIALISTA
ES186	MARIO GERMAN OROZCO SANDOVAL	ANESTESIOLOGO
MG303	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RIOS	AYUDANTE



FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA
Reg. 76-9390/95
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****